



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN
PELAYANAN HIV/AIDS**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor : 895.2/I-PDM/HIV/X/2025

Tentang

Pedoman Pelayanan HIV/AIDS

Disusun oleh :
Ketua Tim HIV/AIDS RS Prima Husada Malang



(dr.Yuniar Ardi Santoso)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes AFP)

Ditetapkan oleh :
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Resti Lestanti,M.Kes)

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
NOMOR : 895.2/I-PDM/HIV/X/2025

TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN HIV/AIDS

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan HIV AIDS termasuk Pelayanan Skrining HIV AIDS di Rumah Sakit Prima Husada Malang, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang profesional, terstandart, terintegritas dan bermutu tinggi;
 - b. Bahwa agar pelayanan HIV/AIDS di Rumah Sakit Prima Husada Malang dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang pedoman Pelayanan HIV/AIDS di Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai acuan bagi penyelenggaraan pelayanan HIV/AIDS di Rumah Sakit Prima Husada Malang
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Kebijakan Pelayanan HIV/AIDS;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang penanggulangan HIV
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
 - 8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
 - 9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 1042.92/DPM/I-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN HIV/AIDS

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV menjadi acuan bagi tenaga kesehatan, pengelola program, kelompok profesi yang menjadi konselor HIV, pengelola/pengurus tempat kerja, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam penyelenggaraan Konseling dan Tes

HIV.

Pasal 2

Konseling dan Tes HIV dilakukan dalam rangka penegakan diagnosis HIV dan AIDS, untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV dan pengobatan lebih dini.

Pasal 3

1. Konseling dan Tes HIV dilakukan melalui pendekatan:
 - a. Konseling dan Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan (KTIP); dan
 - b. Konseling dan Tes HIV Sukarela (KTS).
2. Konseling dan Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan (KTIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
3. Konseling dan Tes HIV Sukarela (KTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Konseling dan Tes HIV terintegrasi dengan pelayanan KIA, KB, pelayanan kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan remaja, pelayanan IMS, pelayanan TB, pelayanan Hepatitis

Pasal 5

Apabila dalam memberikan pelayanan Konseling dan Tes HIV diketahui pasien terinfeksi HIV, maka Petugas kesehatan atau konselor HIV wajib menganjurkan atau memberikan pengobatan sesuai kewenangannya

Pasal 6

- (1). Terdapat Tim HIV yang ditetapkan oleh Rumah Sakit dengan rincian tugas dan tanggungjawabnya
- (2). Tim HIV diketuai oleh dokter

Pasal 7

Rumah Sakit menetapkan regulasi tentang pelaksanaan Pelayanan HIV/AIDS

Pasal 8

- (1). Rumah Sakit dalam melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS sesuai standart pelayanan bagi rujukan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan satelitnta sesuai dengan maksud dan tujuan.
- (2). Maksud dan tujuan yang dimaksud pasal (2) yaitu Rumah sakit melaksanakan program HIV sesuai dengan pedoman HIV yang berlaku dengan langkah langkah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan fungsi pelayanan *Voluntary Counseling And Testing* (VCT)

- b. Meningkatkan fungsi pelayanan *Antiretroviral Therapy* (ART) atau bekerjasama dengan rumah sakit yang ditunjuk
- c. Meningkatkan Fungsi pelayanan Infeksi Oportunistik (IO)
- d. Meningkatkan fungsi pelayanan infeksi oportunistik (IO)\Meningkatkan fungsi pelayanan pada ODHA dengan factor resiko Injection Drug Use (IDU)
- e. Meningkatkan fungsi pelayanan penunjang yang meliputi pelayanan gizi, laboratorium dan radiologi, pencatatan dan pelaporan

Pasal 9

- (1). Rumah sakit telah menetapkan fungsi rujukan HIV/AIDS pada rumah sakit sesuai dengan kebijakan yang berlaku
- (2). Terdapat bukti pelaksanaan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan
- (3). Terdapat daftar pasien HIV/AIDS yang dirujuk
- (4). Terdapat bukti kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan

Pasal 10

- (1). Terdapat laporan tentang pelaksanaan program HIV/AIDS
- (2). Terdapat laporan tentang monitoring dan evaluasi secara rutin program HIV/AIDS

Pasal 11

- (1). Setiap pelayanan Konseling dan Tes HIV harus dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2). Pencatatan Konseling dan Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dalam rekam medik.
- (3). Pelaporan Konseling dan Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang setiap 1 (satu) bulan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 02 Oktober 2025
PLT Direktur RS Prima Husada,



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 895.2/I-PDM/HIV/X/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN HIV/AIDS

PEDOMAN PELAYANAN HIV/AIDS
DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan infeksi menular seksual (IMS) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia dan Indonesia, dan meluas hingga masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Orang yang terinfeksi HIV (ODHIV) sampai saat ini masih mengalami stigma, baik di keluarga, petugas kesehatan, dan masyarakat umum. Stigma terjadi karena kurangnya pengetahuan dan adanya pemahaman yang keliru terhadap HIV dan *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome* (AIDS).

Infeksi menular seksual merupakan salah satu di antara lima kategori penyakit terbanyak yang menyebabkan orang dewasa mencari di negara- negara berpenghasilan menengah dan rendah. Penyakit IMS menyebabkan masalah kesehatan seksual dan reproduksi, antara lain kematian janin dan bayi baru lahir (neonatal) akibat sifilis kongenital, infertilitas akibat infeksi klamidia (klamidiosis) dan gonore yang tidak diobati, serta pengobatan berkembangnya gonore resisten obat antibiotika. Di samping itu, IMS juga menjadi beban anggaran nasional dan rumah tangga.

Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS memiliki manfaat kesehatan masyarakat yang luas dan berkontribusi pada kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030, terkait dengan mengakhiri kematian yang dapat dicegah dari anak berusia di bawah 5 tahun, memerangi penyakit menular (SDG 3.3), termasuk HIV, AIDS, IMS, dan menyediakan akses universal untuk perawatan kesehatan reproduksi (SDG 3.7).

Pemerintah berkomitmen untuk mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030, termasuk eliminasi penularan HIV dari ibu ke anak dan eliminasi sifilis kongenital. Komitmen tersebut ditandai dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan dan peningkatan pendanaan. Dalam upaya mengakhir epidemi AIDS pada tahun 2030 dan eliminasi IMS, beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain:

1. cakupan penemuan kasus HIV belum mencapai target;
2. akses dan cakupan ODHIV pada pengobatan ARV dan keberlanjutan pengobatan perlu ditingkatkan;
3. akses ODHIV pada pemeriksaan *viral load* HIV perlu ditingkatkan/ diperluas;
4. akses ODHIV pada terapi pencegahan TBC dan infeksi oportunistik perlu ditingkatkan;
5. cakupan pencegahan HIV dan Sifilis dari ibu ke anak perlu ditingkatkan, khususnya akses deteksi dini HIV dan Sifilis, pengobatan ARV bagi ODHIV hamil dan pencegahan bagi anaknya;

6. kurangnya penyediaan informasi dan penerapan strategi komunikasi dan edukasi untuk perubahan perilaku pada populasi kunci, dan didukung dengan penyediaan akses masyarakat pada deteksi dini/ skrining IMS dan HIV, dan
7. stigma dan diskriminasi yang masih dialami ODHIV.

Pemerintah melakukan upaya percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS, mulai dari :

1. peningkatan akses dan penambahan jumlah layanan pencegahan, tes, dan pengobatan HIV dan IMS, termasuk pemenuhan kebutuhan logistik obat dan non-obat,
2. eliminasi penularan infeksi HIV, sifilis dan bersamaan dengan hepatitis B dari ibu ke anak (tripel eliminasi),
3. pengembangan kapasitas laboratorium kesehatan untuk pemeriksaan HIV, AIDS, dan IMS, serta perbaikan dan inovasi termasuk penggunaan teknologi dalam penyediaan data dan informasi serta pemantauan pelaksanaan kegiatan penanggulangan. Karena diperlukan regulasi dan penyesuaian pedoman yang ada dengan rekomendasi global, pendekatan kesehatan masyarakat dan perkembangan ilmu kedokteran, yang telah terbukti efektif untuk Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS, maka disusunlah Pedoman Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS yang lebih komprehensif.

1.2 Tujuan Dan Fungsi Pedoman Pelayanan

1.2.1 Tujuan umum

Meningkatkan mutu pelayanan HIV/AIDS di Rumah Sakit Prima Husada Malang

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Sebagai Pedoman bagi semua jajaran pelaksana pelayanan terutama pelayanan HIV/AIDS di Rumah Sakit Prima Husada Malang
2. Menurunkan angka kesakitan HIV

1.2.3 Fungsi Pelayanan HIV/AIDS

1. Terbentuknya Tim HIV/AIDS Rumah Sakit
2. Tercapainya kemampuan teknis Tim HIV sesuai standar
3. Meningkatkan kualitas Pelayanan HIV/AIDS yang bermutu dalam upaya penurunan Angka HIV/AIDS di Indonesia
4. Terlaksananya manajemen pelayanan HIV/AIDS dari aspek administrasi & manajemen, kompetensi SDM, fasilitas dan sarana serta prosedur pelayanan di RS
5. Terlaksananya system rujukan pelayanan HIV/AIDS
6. Menstandarisasi layanan kesehatan di rumah sakit yang sesuai dengan akreditasi.

1.3 Ruang Lingkup Pelayanan

Pedoman ini memberikan panduan bagi petugas kesehatan Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam melaksanakan pelayanan HIV AIDS selama memberikan pelayanan kepada pasien dan pengunjung Rumah Sakit. Pedoman ini memuat segala aspek-aspek yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit Prima Husada Malang, sedangkan aspek- aspek khusus yang berlaku pada unit/instalasi tertentu pula dijabarkan dalam SPO unit/ instalasi tersebut.

1.4 Pengertian Dan Batasan Operasional

1. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome*.
2. *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala dan tanda infeksi yang berhubungan dengan penurunan sistem kekebalan tubuh yang didapat karena infeksi HIV.
3. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus, dan oral/dengan mulut.
4. Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk:
 - a. menurunkan angka kesakitan, kecacatan, atau kematian;
 - b. membatasi penularan HIV, AIDS, dan IMS agar tidak meluas; dan
 - c. mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
5. Orang Dengan HIV yang selanjutnya disingkat ODHIV adalah orang yang terinfeksi HIV.
6. Antiretroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat yang diberikan untuk pengobatan infeksi HIV untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perkembangan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
8. Pedoman ini dapat dijadikan acuan bagi Dokter, Perawat, Petugas laboratorium dan Tim medis lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama pada pasien yang tersangka atau terindikasi tertular HIV/AIDS berdasarkan tanda dan gejala HIV/AIDS, melalui proses skrining yang dilakukan oleh petugas

BAB II
STANDAR KETENAGAAN

2.1. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Sumber daya insani merupakan salah satu komponen yang paling penting untuk mendukung dan memberikan pelayanan HIV AIDS yang berkesinambungan. Pengetahuan dan sikap sumber daya insani dalam hal ini adalah petugas kesehatan akan mempengaruhi keefektifan penyediaan pelayanan HIV AIDS. Petugas kesehatan yang memberikan pelayanan HIV AIDS Rumah Sakit Prima Husada sudah mempunyai ketrampilan klinik dengan mengikuti training yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan HIV AIDS harus mendapatkan pelatihan yang lebih spesifik dan secara khusus. Pelayanan HIV AIDS membutuhkan tenaga kesehatan yang berdedikasi dan mempunyai ketrampilan yang memadai. Adapun petugas pelayanan HIV AIDS terdiri dari :

No	Nama Jabatan	Pendidikan	Sertifikasi	Jumlah Kebutuhan
1	Ketua Tim	Dokter umum	S1 Kedokteran	1
2	Sekretaris	Perawat/Bidan	DIV/S1 Kebidanan	1
3	Anggota	Analisis	DIII/ S1 analisis	1
4	Anggota	Rekam Medis	DIII/ S1	1
Total				4

2.1 Distribusi Ketenagaan.

Pelayanan HIV/AIDS dipimpin oleh dokter dan staf yang terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan yang berkualitas untuk menjamin dilaksanakannya pelayanan yang telah ditentukan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Ketua Tim HIV adalah dokter umum yang terlatih
- 2. Perawat Ruangan, IGD maupun Rawa jalan yang terlatih
- 3. Petugas Laboratorium yang terlatih
- 4. Petugas administrasi yang terlatih

2.2 Pengaturan Jaga / Dinas. Jam Dinas Tim HIV

Tabel 2. Pengaturan Jaga / Dinas. Jam Dinas Tim HIV

No	Nama Jabatan	Waktu Kerja	Definisi Waktu Kerja	Jumlah SDM
1	Ketua Tim	Sesuai jadwal konsulan	24 jam	2 Orang
2	Sekretaris	Sesuai jadwal konsulan	24 jam	3 orang
3	Anggota	Sesuai jadwal konsulan	24 jam	2 Orang
4	Anggota	3 shif	Jam 06.30-14.30	4 orang
			Jam 14.00-21.00	4 orang
			Jam 21.00-07.00	3 orang

BAB III

STANDAR FASILITAS.

A. Standar Fasilitas

a) Sarana

1) Papan petunjuk

Papan petunjuk dipasang yang jelas untuk memudahkan akses klien ke klinik VCT. Di depan ruang klinik VCT bertuliskan Pelayanan VCT / Klinik VCT / Ruang konseling

2) Ruang Tunggu

Ruang tunggu berada di depan ruang konseling atau disamping tempat pengambilan sampel darah.

Diruang tunggu tersedia:

- Materi KIE : poster, leaflet, brosur yang berisi tentang HIV AIDS, IMS, KB, ANC, TB, Hepatitis, Penyalahgunaan Napza, Perilaku sehat, Nutrisi dan seks yang aman
- Informasi konseling dan testing
- Kotak saran
- Tempat sampah, tissue, air minum
- TV, video
- Buku catatan resepsionis untuk perjanjian klien atau komputer
- Meja dan kursi
- Kalender

b) Jam pelayanan HIV AIDS

Jam pelayanan konseling dan testing terintegrasi dalam jam pelayanan kesehatan lainnya, bisa dilakukan pada pagi dari jam 08.00 sampai 14.00.

c) Ruang Konseling

Ruang konseling disediakan nyaman mungkin dan terjaga kerahasiaannya serta terpisah dari ruang tunggu. Ruang konseling terdapat dua pintu yaitu pintu masuk dan pintu keluar klien sehingga klien yang selesai konseling dan klien berikutnya yang akan konseling tidak saling bertemu.

Ruang Konseling dilengkapi :

- 1 meja dan 3 kursi (Tempat duduk bagi klien maupun konselor)
- Buku catatan perjanjian klien dan catatan harian, formulir informed consent, catatan medis klien, formulir pre dan pasca testing, buku rujukan, formulir rujukan, kalender dan ATK
- Kondom dan alat peraga penis, alat peraga reproduksi wanita
- Buku resep gizi seimbang
- Tisu
- Air minum
- Lemari arsip / lemari dokumen yang dapat dikunci

d) Ruang Pengambilan Sampel Darah dekat dengan ruang konseling

Meja yang dilengkapi Peralatan :

- Jarum vacutainer
- Tabung vacutainer
- Holdervacutainer
- Alkohol swab
- Plester
- Wadah limbah tahan tusukan
- Coolbox container

-
- Sarung tangan karet
 - Apron plastic
 - Tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun Tempat sampah infeksius dan non infeksius

e) Ruang petugas kesehatan Berisi :

- Meja dan kursi
- Tempat pemeriksaan fisik
- Stetoskop dan tensimeter
- Blangko resep
- Alat timbangan badan
- KIE HIV AIDS

f) Prasarana

1) Aliran Listrik

Diperlukan untuk penerangan yang cukup baik, untuk membaca, menulis serta untuk pendingin ruangan

2) Air

Diperlukan air mengalir untuk menjaga kebersihan ruangan dan mencuci tangan serta membersihkan alat-alat

3) Sambungan Telepon

Diperlukan terutama untuk komunikasi dengan layanan lain yang terkait

4) Pembuangan Limbah Padat dan Limbah Cair

Mengacu kepada pedoman kewaspadaan transmisi di pelayanan kesehatan tentang pengolahan limbah.

BAB IV
KEMAMPUAN LAYANAN

1. Terkait Kemampuan layanan HIV/AIDS di RS Prima Husada Malang yaitu layanan Konseling dan Tes HIV(KTHIV). Dimana RS hanya bisa melakukan pelayanan screening pemeriksaan HIV tanpa melakukan pengobatan lanjutan
2. Konseling dan Tes HIV dilakukan dalam rangka penegakan diagnosis HIV dan AIDS, untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV dan pengobatan lebih dini
3. Konseling dan Tes HIV dilakukan melalui pendekatan:
 - a. Konseling dan Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan (KTIP); dan
 - b. Konseling dan Tes HIV Sukarela (KTS).
4. Konseling dan Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan (KTIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
5. Konseling dan Tes HIV Sukarela (KTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
6. Penyelenggaraan Konseling dan Tes HIV terintegrasi dengan pelayanan KIA, KB, pelayanan kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan remaja, pelayanan IMS, pelayanan TB, pelayanan Hepatitis
7. Terdapat Tim HIV yang ditetapkan oleh Rumah Sakit dengan rincian tugas dan tanggungjawabnya dan Tim HIV diketuai oleh dokter
8. Rumah Sakit dalam melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS sesuai standart pelayanan bagi rujukan orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
9. Maksud dan tujuan yang dimaksud yaitu Rumah sakit melaksanakan program HIV sesuai dengan pedoman HIV yang berlaku dengan langkah langkah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan fungsi pelayanan *Voluntary Counseling And Testing* (VCT)
 - b. Meningkatkan fungsi pelayanan *Antiretroviral Therapy* (ART) atau bekerjasama dengan rumah sakit yang ditunjuk
 - c. Meningkatkan Fungsi pelayanan Infeksi Oportunistik (IO)
 - d. Meningkatkan fungsi pelayanan infeksi oportunistik (IO)\Meningkatkan fungsi pelayanan pada ODHA dengan factor resiko Injection Drug Use (IDU)
 - e. Meningkatkan fungsi pelayanan penunjang yang meliputi pelayanan gizi, laboratorium dan radiologi, pencatatan dan pelaporan
10. Setiap pelayanan Konseling dan Tes HIV harus dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Pencatatan Konseling dan Tes HIV didokumentasikan dalam rekam medik.
12. Pelaporan Konseling dan Tes HIV dilakukan secara berjenjang setiap 1 (satu) bulan.
13. Rumah sakit telah menetapkan fungsi rujukan HIV/AIDS pada rumah sakit sesuai dengan kebijakan yang berlaku
14. Terdapat bukti pelaksanaan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan
15. Terdapat daftar pasien HIV/AIDS yang dirujuk
16. Terdapat bukti kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
17. Terdapat laporan tentang pelaksanaan program HIV/AIDS
18. Terdapat laporan tentang monitoring dan evaluasi secara rutin program HIV/AIDS

BAB V

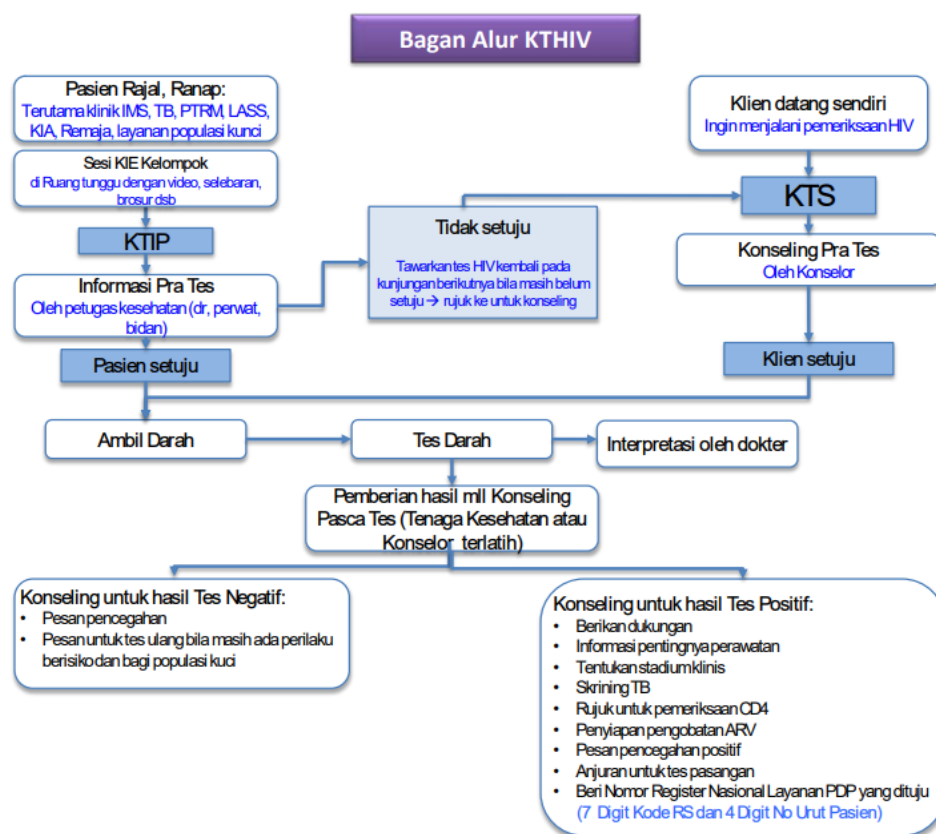
TATA LAKSANA PELAYANAN HIV/AIDS

Penyelenggaraan Konseling dan Tes HIV(KTHIV) adalah suatu layanan untuk mengetahui adanya infeksi HIV di tubuh seseorang. Layanan ini dapat diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan. KTHIV didahului dengan dialog antara klien/pasien dan konselor/petugas kesehatan dengan tujuan memberikan informasi tentang HIV dan AIDS dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berkaitan dengan tes HIV. Layanan KTHIV untuk menegakkan diagnosis HIV, dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu:

1. Konseling dan Tes HIV atas inisiatif pemberi layanan kesehatan dan konseling yang disingkat dengan KTIP
2. Konseling dan tes HIV secara sukarela yang disingkat dengan KTS

Alur KTHIV dengan pendekatan KTIP maupun KTS di fasilitas layanan kesehatan tergambar pada Bagan 1 di bawah ini:

Bagan 1. Alur KTHIV



Beberapa alasan seseorang melakukan KTHIV adalah:

1. Orang atau pasangan yang ingin mengetahui status HIVnya
2. Ibu hamil yang masuk dalam Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA)
3. Penegakan diagnosis untuk keperluan pasien (pasien Hepatitis, pasien TB, pasien IMS, ibu hamil, bayi yang lahir dari ibu dengan HIV)
4. Pasien yang diduga telah terinfeksi HIV
5. Penapisan darah donor transfusi atau organ tubuh
6. Tata laksana Profilaksis Pasca Paparan (PPP) setelah terjadinya tusukan pada kecelakaan kerja okupasional
7. Prosedur pemeriksaan dalam kasus perkosaan
8. Perintah pengadilan dari terdakwa dalam kasus kejahatan seksual dan sebagainya.

A. Konseling Pretesting

1. Penerimaan klien :

- Informasikan kepada klien tentang pelayanan tanpa nama, sehingga nama tidak ditanyakan
- Pastikan klien tepat waktu dan tidak menunggu

- Buat catatan rekam medic klien dan pastikan setiap klien mempunyai kodenya sendiri
- Kartu pemeriksaan konseling dan testing dengan nomor kode dan ditulis oleh konselor.

Tanggung jawab klien dalam konselor:

- 1) Bersama konselor mendiskusikan hal-hal terkait tentang HIV AIDS, perilaku beresiko, testing HIV dan pertimbangan yang terkait dengan hasil negative atau positif
- 2) Sesudah melaksanakan konseling lanjutan diharapkan dapat melindungi diri dan keluarganya dari penyebaran infeksi
- 3) Untuk klien yang dengan HIV positif memberitahu pasangan atau keluarganya akan status dirinya dan rencana kehidupan lebih lanjut

2. Konseling Pre testing

- 1) Periksa ulang nomor kode dalam formulir
- 2) Perkenalan dan arahan
- 3) Menciptakan kepercayaan klien pada konselor, sehingga terjalin hubungan baik dan terbina saling memahami
- 4) Alasan kunjungan
- 5) Penilaian resiko agar klien mengetahui factor resiko dan menyiapkan diri untuk pre test
- 6) Memberikan pengetahuan akan implikasi terinfeksi atau tidak terinfeksi
- 7) Konselor membuat keseimbangan antara pemberian informasi, penilaian resiko dan merespon kebutuhan emosi klien
- 8) Konselor PDP membuat penilaian system dukungan
- 9) Klien memberikan persetujuan tertulis sebelum tes HIV dilakukan

B. Informed consent

1. Semua klien sebelum menjalani tes HIV harus memberikan persetujuan tertulis. Aspek penting dalam persetujuan tertulis adalah :
 - 1) Klien diberi penjelasan tentang resiko dan dampak sebagai akibat tindakan dan klien menyetujuinya
 - 2) Klien mempunyai kemampuan mengerti/ memahami dan menyatakan persetujuannya
 - 3) Klien tidak dalam terpaksa memberikan persetujuannya
 - 4) Untuk klien yang tidak mampu mengambil keputusan karena keterbatasan dalam memahami, maka konselor berlaku jujur dan obyektif dalam menyampaikan informasi.
2. Informed consent pada anak

Bahwa anak memiliki keterbatasan kemampuan berfikir dan menimbang ketika dihadapkan dengan HIV AIDS. Jika mungkin anak didorong untuk menyertakan orang tua atau wali, namun apabila anak tidak menghendaki, maka layanan PDP disesuaikan dengan kemampuan anak untuk menerima dan memproses serta memahami informasi hasil testing HIV AIDS. Dalam melakukan testing HIV pada anak dibutuhkan persetujuan orang tua / wali.
3. Batasan umur untuk persetujuan

Anak berumur dibawah 12 tahun orang tua / wali yang menandatangani informed consent, jika tak mempunyai orang tua / wali maka kepala institusi, kepala puskesmas, kepala rumah sakit, kepala klinik atau siapa yang bertanggungjawab atas diri anak harus menandatangani informed consent. Jika anak dibawah umur 12 tahun memerlukan testing HIV maka orang tua atau wali harus mendampingi secara penuh
4. Persetujuan orang tua untuk anak

Orang tua dapat memberikan persetujuan konseling dan testing HIV AIDS untuk anaknya. Namun sebelum meminta persetujuan, konselor melakukan penilaian akan situasi anak, apakah melakukan tes HIV lebih baik atau tidak. Jika orang tua bersikeras ingin mengetahui status anak, maka konselor melakukan konseling dahulu dan apakah orang tua akan menempatkan pengetahuan atas status HIV anak untuk kebaikan atau

merugikan anak. Jika konselor ragu maka bimbinglah anak untuk didampingi tenaga ahli. Anak senantiasa diberitahu betapa penting hadirnya seseorang yang bermakna dalam kehidupannya untuk mengetahui kesehatan dirinya.

C. Testing HIV dalam VCT

Prinsip testing HIV adalah terjaga kerahasiaannya. Testing dimaksudkan untuk menegakkan diagnose. Penggunaan testing cepat (rapid testing) memungkinkan klien mendapatkan hasil testing pada hari yang sama.

Tujuan testing adalah :

- a. Untuk menegakkan diagnosis
- b. Pengamanan darah donor (skrining)
- c. Untuk surveilans
- d. Untuk penelitian

Petugas laboratorium harus menjaga mutu dan konfidensialitas, hindari terjadinya kesalahan baik teknis (technical error), manusia (human error) dan administrative (administrative error).

Bagi pengambil sampel darah harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Sebelum testing dilakukan harus didahului dengan konseling dan informed consent
- b. Hasil testing diverifikasi oleh dokter patologi klinis
- c. Hasil diberikan dalam amplop tertutup
- d. Dalam laporan pemeriksaan ditulis kode register
- e. Jangan memberi tanda menyolok terhadap hasil positif atau negative
- f. Meski sampel berasal dari sarana kesehatan yang berbeda tetap dipastikan telah mendapat konseling dan menandatangani informed consent

D. Konseling pasca testing

Kunci utama dalam menyampaikan hasil testing :

- a) Periksa ulang seluruh hasil klien dalam rekam medic. Lakukan sebelum bertemu klien
- b) Sampaikan kepada klien secara tatap muka
- c) Berhati-hati memanggil klien dari ruang tunggu
- d) Seorang konselor tidak diperkenankan menyampaikan hasil tes dengan cara verbal maupun non verbal di ruang tunggu.
- e) Hasil test harus tertulis

Tahapan penatalaksanaan konseling pasca testing :

- a. Penerimaan klien
 - Memanggil klien dengan kode register
 - Pastikan klien hadir tepat waktu dan usahakan tidak menunggu
 - Ingat akan semua kunci utama dalam penyampaian hasil testing
- b. Pedoman penyampaian hasil negative
 - Periksa kemungkinan terpapar dalam periode jendela
 - Gali lebih lanjut berbagai hambatan untuk seks yang aman
 - Kembali periksa reaksi emosi yang ada
 - Buat rencana tindak lanjut
- c. Pedoman penyampaian hasil positif
 - Perhatikan komunikasi non verbal saat klien memasuki ruang konseling
 - Pastikan klien siap menerima hasil
 - Tekankan kerahasiaan
 - Lakukan penyampaian secara jelas dan langsung
 - Sediakan waktu cukup untuk menyerap informasi tentang hasil
 - Periksa apa yang diketahui klien tentang hasil
 - Dengan tenang bicarakan apa arti hasil pemeriksaan
 - Ventilasikan emosi klien

d. Konfidensialitas

Penjelasan secara rinci pada saat konseling pretes dan persetujuan dituliskan dan dicantumkan dalam catatan medic. Berbagi konfidensialitas adalah rahasia diperluas kepada orang lain, terlebih dahulu dibicarakan kepada klien. Orang lain yang dimaksud adalah anggota keluarga, orang yang dicintai, orang yang merawat, teman yang dipercaya atau rujukan pelayanan lainnya ke pelayanan medic dan keselamatan klien. Selain itu juga disampaikan jika dibutuhkan untuk kepentingan hukum.

e. VCT dan etik pemberitahuan kepada pasangan

Dalam konteks HIV AIDS, WHO mendorong pengungkapan status HIV AIDS. Pengungkapan bersifat sukarela, menghargai otonomi dan martabat individu yang terinfeksi, pertahankan kerahasiaan sejauh mungkin menuju kepada hasil yang lebih menguntungkan individu, pasangan seksual dan keluarga, membawa keterbukaan lebih besar kepada masyarakat tentang HIV AIDS dan memenuhi etik sehingga memaksimalkan hubungan baik antara mereka yang terinfeksi dan tidak.

f. Isu-isu gender

Gender adalah sama pentingnya dengan memusatkan perhatian terhadap penggunaan kondom, dengan konsistensi tetap bertahan menggunakan kondom merupakan bentuk perubahan perilaku.

E. Pelayanan Dukungan Berkelanjutan

a. Konseling Lanjutan

Salah satu layanan yang ditawarkan kepada klien adalah konseling lanjutan sebagai bagian layanan PDP apapun hasil testing yang diterima klien. Namun karena persepsi klien berbeda-beda terhadap hasil testing maka konseling lanjutan ini sebagai pilihan jika dibutuhkan klien untuk menyesuaikan diri dengan status HIV.

b. Kelompok Dukungan PDP

Layanan ini dapat ditempatkan layanan klinik PDP dan di Masyarakat. Konselor atau kelompok ODHA akan membantu klien baik dengan hasil positif maupun negative untuk bergabung dalam kelompok ini. Kelompok ini dapat diikuti oleh pasangan dan keluarga

c. Pelayanan Penanganan Manajemen Kasus

Tahapan dalam manajemen kasus, adalah identifikasi, penilaian kebutuhan pengembangan rencana tidak individu, rujukan sesuai kebutuhan dan tepat serta koordinasi tindak lanjut.

d. Perawatan dan Dukungan

Setelah diagnosis ditegakkan dengan HIV positif maka klien dirujuk dengan pertimbangan akan kebutuhan rawatan dan dukungan. Kesempatan ini digunakan klien dan klinisi untuk menyusun rencana dan jadwal pertemuan konseling selanjutnya dimana membutuhkan tindakan medic lebih lanjut, seperti terapi profilaksis dan akses ke ART.

e. Layanan Psikiatrik

Banyak pengguna Zat psikoaktif saat menerima hasil positif testing HIV, meskipun sudah dipersiapkan terlebih dahulu, klien dapat mengalami goncangan yang berat, seperti depresi, panik, kecemasan yang hebat, agresif bahkan bunuh diri. Bila terjadi hal demikian maka perlu dirujuk ke fasilitas layanan psikiatri.

f. Konseling Kepatuhan Berobat

Dibutuhkan waktu untuk memberikan edukasi dan persiapan guna meningkatkan kepatuhan sebelum dimulai terapi ARV. Sekali dimulai harus dilakukan monitoring terus menerus yang dinilai oleh dokter, jumlah obat dan divalidasi dengan daftar pertanyaan kepada pasien. Konseling ini membantu klien mencari jalan keluar dari kesulitan yang mungkin timbul dari pemberian terapi dan mempengaruhi kepatuhan.

g. Rujukan

Pelayanan PDP bekerja dengan membangun hubungan antara masyarakat dan rujukan yang sesuai dengan kebutuhannya serta memastikan rujukan dari masyarakat ke pusat PDP.

Sistem rujukan dan alur :

1. Rujukan klien dalam lingkungan sarana kesehatan.

Jika dokter mencurigai seseorang menderita HIV, maka dokter merekomendasikan klien dirujuk ke konselor yang ada di RS.

2. Rujukan antar sarana kesehatan

- a) Rujukan klien dari sarana kesehatan ke sarana kesehatan lainnya Rujukan ini dilakukan secara timbal balik dan berulang sesuai dengan kebutuhan klien.
- b) Rujukan klien dari sarana kesehatan lainnya ke sarana kesehatan rujukan. Dari sarana kesehatan lainnya ke sarana kesehatan dapat berupa rujukan medik klien, rujukan spesimen, rujukan tindakan medik lanjut atau spesialisasi.

BAB V LOGISTIK

Standar Fasilitas

Sarana

1) Papan petunjuk

Papan petunjuk dipasang yang jelas untuk memudahkan akses klien ke klinik VCT. Di depan ruang klinik VCT bertuliskan Pelayanan VCT / Klinik VCT / Ruang konseling

2) Ruang Tunggu

Ruang tunggu berada di depan ruang konseling atau disamping tempat pengambilan sampel darah.

Diruang tunggu tersedia:

- Materi KIE : poster, leaflet, brosur yang berisi tentang HIV AIDS, IMS, KB, ANC, TB, Hepatitis, Penyalahgunaan Napza, Perilaku sehat, Nutrisi dan seks yang aman
- Informasi konseling dan testing
- Kotak saran
- Tempat sampah, tissue, air minum
- TV, video
- Buku catatan resepsionis untuk perjanjian klien atau komputer
- Meja dan kursi
- Kalender

3) Ruang Konseling

Ruang konseling disediakan se nyaman mungkin dan terjaga kerahasiaannya serta terpisah dari ruang tunggu. Ruang konseling terdapat dua pintu yaitu pintu masuk dan pintu keluar klien sehingga klien yang selesai konseling dan klien berikutnya yang akan konseling tidak saling bertemu.

Ruang Konseling dilengkapi :

- 1 meja dan 3 kursi (Tempat duduk bagi klien maupun konselor)
- Buku catatan perjanjian klien dan catatan harian, formulir informed consent, catatan medis klien, formulir pre dan pasca testing, buku rujukan, formulir rujukan, kalender dan ATK
- Kondom dan alat peraga penis, alat peraga reproduksi wanita
- Buku resep gizi seimbang
- Tisu
- Air minum
- Lemari arsip / lemari dokumen yang dapat dikunci

4) Ruang Pengambilan Sampel Darah dekat dengan ruang konseling Meja yang dilengkapi Peralatan :

- Jarum vacuntainer
- Tabung vacuntainer
- Holdervacuntainer
- Alkohol swab
- Plester
- Wadah limbah tahan tusukan
- Coolbox container
- Sarung tangan karet
- Apron plastic
- Tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun Tempat sampah infeksius dan non infeksius

5) Ruang petugas kesehatan Berisi :

- Meja dan kursi

-
- Tempat pemeriksaan fisik
 - Stetoskop dan tensimeter
 - Blangko resep
 - Alat timbangan badan
 - KIE HIV AIDS

Prasarana

a. Aliran Listrik

Diperlukan untuk penerangan yang cukup baik, untuk membaca, menulis serta untuk pendingin ruangan

b. Air

Diperlukan air mengalir untuk menjaga kebersihan ruangan dan mencuci tangan serta membersihkan alat-alat

c. Sambungan Telepon

Diperlukan terutama untuk komunikasi dengan layanan lain yang terkait

d. Pembuangan Limbah Padat dan Limbah Cair

Mengacu kepada pedoman kewaspadaan transmisi dipelayanan kesehatan tentang pengolahan limbah.

BAB VI KESELAMATAN PASIEN

Kewaspadaan merupakan upaya pencegahan infeksi yang mengalami perjalanan panjang. Mulai dari infeksi nosokomial yang menjadi ancaman bagi petugas kesehatan dan pasien. Seperangkat prosedur dan pedoman yang dirancang untuk mencegah terjadinya infeksi pada tenaga kesehatan dan juga memutus rantai penularan ke pasien. Terutama untuk mencegah penularan melalui darah dan cairan tubuh, seperti: HIV dan HBV → juga patogen lain.

Prinsip Kewaspadaan Umum dijabarkan dalam 5 kegiatan pokok yaitu :

1. Cuci tangan guna mencegah infeksi silang
Cuci tangan dilakukan :
 - a. Setelah menyentuh darah, cairan tubuh, sekresi dan bahan terkontaminasi lain.
 - b. Segera setelah melepas sarung tangan.
 - c. Diantara kontak dengan pasien
 - d. Tidak direkomendasikan mencuci tangan saat masih memakai sarung tangan
 - e. Cuci tangan 6 langkah.
 - f. Prosedur terpenting untuk mencegah tranmisi penyebab infeksi
 - g. Antiseptik dan air mengalir atau handrub
2. Pemakaian Alat Pelindung Diri/ perorangan (APP)
 - a. Sarung Tangan
 - b. Pelindung Muka
 - c. Masker
 - d. Kaca Mata/ *goggle*
 - e. Gaun/Jubah/Apron
 - f. Pelindung Kaki
3. Pengelolaan alat kesehatan bekas pakai (Dekontaminasi, sterilisasi, disinfeksi)
 - a. Dekontaminasi : Suatu proses menghilangkan mikroorganisme patogen dan kotoran dari suatu benda sehingga aman untuk pengelolaan alkes bekas pakai
 - b. Pencucian : Proses secara fisik untuk menghilangkan kotoran terutama bekas darah, cairan tubuh dan benda asing lainnya seperti debu, kotoran yang menempel di kulit atau alat kesehatan
 - c. Disinfeksi : Suatu proses untuk menghilangkan sebagian mikroorganisme
 - d. Disinfeksi Tingkat Tinggi = DTT
 - (1) Suatu proses untuk menghilangkan mikroorganisme dari alat kesehatan kecuali beberapa endospora bakteri
 - (2) Alternatif penanganan alkes apabila tdk tersedia sterilisator atau tdk mungkin dilaksanakan.
 - (3) Dapat membunuh Mikroorganisme (hep B, HIV), namun tdk membunuh endospora dengan sempurna seperti tetanus.
 - e. Sterilisasi.
Suatu proses untuk menghilangkan seluruh mikroorganisme termasuk endospora bakteri dari alat kesehatan. Cara yang paling aman utk pengolaan alkes yang berhubungan langsung dgn darah
4. Pengelolaan jarum & alat tajam
Jarum dan alat tajam dimasukkan kedalam safety box kemudiandiolah ditempat pengolahan benda tajam yang ada di RS.
5. Pengelolaan limbah & sanitasi Ruang
Pemilihan Cara Pengelolaan Limbah dan Sanitasi Ruang

-
- a. Limbah Cair
 - b. Sampah Medis
 - c. Sampah Rumah Tangga
 - d. Insinerasi
 - e. Penguburan
 - f. Disinfeksi permukaan
6. Penanganan Linen
- a. Kereta dorong bersih & kotor dipisahkan
 - b. Tidak boleh keluar dan masuk pada jalan yang sama
 - c. Tidak boleh ada perendaman di ruang perawatan
 - d. Pisahkan dalam kantong berwarna kuning untuk linen yang terkontaminasi dengan darah atau kontaminan lain.

BAB VII KESELAMATAN KERJA

1. Perlindungan Diri – PROFILAKSIS PASCA PAJANAN HIV (PPP)

Profilaksis Pasca Pajanan HIV merupakan tindakan pencegahan terhadap petugas kesehatan yang tertular HIV akibat tertusuk jarum, tercemar darah dari penderita atau mayat penderita HIV. Paparan cairan infeksius tidak saja membawa virus HIV tetapi juga virus hepatitis (Hepatitis B maupun C). Perlukaan perkutaneus merupakan kecelakaan kerja tersering dan biasanya disebabkan oleh jarum yang berlubang (*hollow-bore-needle*)

2. Faktor Yang Mempengaruhi.

- a. Jumlah dan jenis cairan yang mengenai.
- b. Dalamnya tusukan/luka.
- c. Tempat perlukaan/paparan.

3. Indikasi Pemberian PPP.

- a. Tertusuk /luka superficial yang merusak kulit oleh jarum solid yang telah terpapar sumber dengan HIV + asimtomatik. Membran mukosa terpapar oleh darah terinfeksi IV dalam jumlah banyak, dari sumber HIV + asimtomatik (tergantung dari banyak tidaknya volume dan tetesan).
- b. Membran mukosa terpapar darah yang terinfeksi HIV + dalam jumlah sedikit, dari sumber dengan HIV + simptomatik.
- c. Terpapar dengan orang HIV + asimtomatik lewat tusukan yang dalam jarum berlubang yang berukuran besar.
- d. Luka tusukan jarum dengan darah yang terlihat di permukaan jarum.
- e. Luka tusukan jarum yang telah digunakan untuk mengambil darah arteri atau vena pasien.
- f. Luka tusuk dari jenis jarum apapun yang telah digunakan pada sumber dengan HIV + yang simptomatik.
- g. Membran mukosa yang terpapar oleh darah yang terinfeksi HIV dalam jumlah yang banyak dari sumber HIV + yang simptomatik.
- h. Tusukan jarum dengan tipe jarum apapun dan berbagai derajat paparan dari sumber dengan status HIV tidak diketahui tetapi memiliki faktor resiko HIV.
- i. Tusukan jarum dengan tipe jarum apapun dan berbagai derajat paparan dari sumber yang tidak diketahui status HIV dan tidak diketahui faktor resikonya, namun dianggap sebagai sumber HIV +.
- j. Membran mukosa yang terpapar darah dalam jumlah berapapun dari sumber yang tidak diketahui status HIV tetapi memiliki faktor resiko HIV.
- k. Membran mukosa yang terpapar darah dalam jumlah berapapun dari sumber yang tidak diketahui status HIV nya, namun sumber tersebut dianggap sebagai sumber HIV +

4. Klasifikasi Katagori Paparan (Exposure category).

Berdasarkan paparan, kadar RNA HIV dan bahan paparan. Terdapat 4 kategori:

- a. EC 1 :
 1. Tempat paparan adalah kulit atau mukosa yang mengalami luka.
 2. Bahan paparan jumlahnya sedikit (tetesan darah atau cairan tubuh yang berdarah).
 3. Waktu paparan cepat (tidak lama).
- b. EC 2 : Seperti EC-1, tetapi jumlah bahan paparan lebih banyak dan waktu paparan lebih lama.
- c. EC2 : Paparan perkutaneus, luka superficial dengan jarum kecil.
- d. EC3 : Seperti EC2, tetapi lewat jarum besar, tertusuk dalam, keluar darah.

5. Penatalaksanaan Pasca Pajanan.

- 1) Keputusan pemberian ARV harus segera diambil dan ARV diberikan <4 jam setelah paparan.

-
- 2) Penanganan luka.
 - 3) Beri informed consent.
 - 4) Lakukan test HIV.
 - 5) Pemberian ARV profilaksis.
 - 6) Penanganan tempat paparan/luka. : Segera!!
 - 7) Luka tusuk → bilas air mengalir dan sabun / antiseptic.
 - 8) Paparan mukosa mulut → ludahkan dan kumur.
 - 9) Paparan mukosa mata → irigasi dg air/ garam fisiologis
 - 10) Paparan mukosa hidung → hembuskan keluar dan bersihkan dengan air
 - 11) Jangan dihisap dengan mulut, jangan ditekan.
6. Disinfeksi luka dan daerah sekitar kulit dengan salah satu :
- a. Betadine (povidone iodine 2.5%) selama 5mnt
 - b. Alcohol 70% selama 3 mnt.
- Catatan :
1. Chlorhexidine cetrimide bekerja melawan HIV tetapi bukan HBV.
 2. Pelaporan terjadinya paparan. Rincian waktu, tempat, paparan dan konseling serta manajemen pasca paparan.
 3. Evaluasi dan risiko transmisi.
 4. Konseling berupa risiko transmisi, pencegahan transmisi sekunder, tidak boleh hamil dsb.
 5. Pertimbangan pemakaian terapi profilaksis pasca paparan.
 6. Pemantauan (follow up).
7. Pemantauan
- Tes Antibodi dilakukan pada minggu ke-6 , minggu ke -12 dan bulan ke 6. Dapat diperpanjang sampai bulan ke 12.
8. Aspek Manajemen.
- a. Merupakan bagian medico legal.
 - b. Perlu dilakukan pencatatan dan evaluasi.
 - c. Evaluasi meliputi :
 - 1) Kesalahan sistem.
 - 2) Tidak ada pelatihan.
 - 3) Tidak ada SOP tidak tersedia alat pelindung diri.
 - 4) Ratio pekerja dan pasien yg tidak seimbang.
 - 5) Kesalahan manusia.
 - 6) Kesalahan dalam penggunaan dan pemilihan alat kerja.
 - 7) Rekomendasi kepada management RS perlu diberikan setelah evaluasi dilakukan.

BAB VIII

PENGENDALIAN MUTU

Salah satu prinsip yang menggaris bawahi implementasi layanan Konseling dan Tes HIV(KTHIV) adalah layanan berkualitas, guna memastikan klien mendapatkan layanan tepat dan menarik orang untuk menggunakan layanan. Tujuan pengukuran dari jaminan kualitas adalah menilai kinerja petugas, kepuasanpelanggan atau klien, dan menilai ketepatan protocol konseling dan testing yang kesemuanya bertujuan tersedianya layanan yang terjamin kualitas dan mutu.

1. Konseling dalam Konseling dan Tes HIV(KTHIV)

Pelayanan konseling dimulai dengan suasana bersahabat yang dilayani oleh konselor terlatih. Perangkat untuk menilai kualitas layanan termasukmengevaluasi kinerja seluruh staff, penilaian kualitas konseling dengan menghadirkan supervisor yang menyamar sebagai klien, melakukan pertemuan berkala dengan para konselor, mengikuti perkembangan konseling dan HIV AIDS, kotak saran, penilaian oleh petugas jasa, mengukur seberapa jauh konselor mengikuti aturan protocol dan supervise suportif yang regular.

Perangkat jaminan mutu konseling

- a. Perangkat rekaman saat konseling dengan klien samaran atau klien sungguhan yang telah memberikan persetujuan untuk direkam.
Kegiatan ini dapat digunakan untuk melakukan pengamatan, melakukan ikhtisar sesudah sesi berlangsung (sesi rekam) atau pengamat ketrampilan konselor) melalui klien samara (tak diketahui konselor, untuk mendapatkan ketepatan pengamatan
- b. Formulir kepuasan pelanggan.
Nomor dan nama klien dicatat. Formulir dimasukkan ke kotak yang aman dan terkunci. Semua komentar dikumpulkan dan dinilai pada pertemuan dengan seluruh petugas. Klien yang tidak dapat menulis/ membaca dapat dibantu relawan. Petugas yang bekerja pada institusitidak diperkenankan membantu pengisian. Baca terlebih dahulu petunjuk dan isi dari formulir, kemudian baru diisi. Klien sama sekali tidak boleh dipengaruhi pendapatnya, administrasi memastikan apakah jawaban klien sudah lengkap dan benar sesuai petunjuk.
- c. Syarat minimal layanan
Penilaian internal atau eksternal dapat menggunakan daftar sederhana apakah pelayanan Konseling dan Tes HIV(KTHIV) memenuhi persyaratan standar minimal yang ditentukan Departemen Kesehatan dan W

BAB IX PENUTUP

1. Sarana Dan Prasarana

Klinik Konseling dan Tes HIV(KTHIV) merupakan pintu utama pelayanan HIV AIDS dalam pemenuhan sarana dan prasarana masih membutuhkan dukungan dari semua pihak.

2. Perangkat Lunak

Tim pencegahan penyakit TB dan HIV AIDS sudah terbentuk, namun dalam melaksanakan kegiatannya masih mengalami banyak kendala dikarenakan Rumah Sakit Prima Husada Malang belum mempunyai pelayanan PDP ini kesemua pihak, baik intern maupun ekstern.

3. Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia dan ketrampilan klinik tentang pelayanan HIV AIDS sudah dilakukan pelatihan oleh dinas kesehatan provinsi secara berkala.

4. Sistem Informasi Dan Jejaring

Rumah Sakit Prima Husada Malang bekerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS daerah dan pemerintah.

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 02 Oktober 2025
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

FORMULIR 1

PERMINTAAN DIAGNOSIS HIV

NOMOR REKAM MEDIS :

KODE KLIEN :

JENIS KELAMIN :

TANGGAL PERMINTAAN PEMERIKSAAN :

Klien sudah mendapat informasi dan atau menandatangani persetujuan Pemeriksaan :

Klien Memiliki Risiko Tertular AIDS : ☐ YA ☐ TIDAK

Klien Menunjukkan Gejala AIDS : ☐ YA ☐ TIDAK

PEMERIKSAAN LABORATORIUM YANG DIMINTA (BERI TANDA CENTANG ✓)

- ☐ PEMERIKSAAN ANTI-HIV
- ☐ PEMERIKSAAN CD4 (hanya untuk yang sudah terdiagnosis HIV)
- ☐ PEMERIKSAAN PCR KUANTITATIF/VIRAL LOAD (hanya untuk yang sudah terdiagnosis HIV)
- ☐ PEMERIKSAAN PCR KUALITATIF (deteksi Dini Pada Bayi Umur 6 Minggu – 18 Bulan Dan Rujukan HIV)

Dokter yang meminta pemeriksaan

(.....)



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

FORMULIR 2

INFORMED CONSENT

Saya yang bertandatangan dibawah ini telah mengerti tentang HIV dan AIDS, memahami prosedur pemeriksaan dan tahu segala akibat yang mungkin timbul dari diketahuinya status HIV saya, serta telah diberikan konseling dengan baik maka saya :

***BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA DIPERIKSA HIV**

Saya menyetujui untuk menjalani pemeriksaan darah HIV dengan ketentuan bahwa hasil tes akan tetap rahasia dan terbuka hanya kepada saya dan untuk tim perawatan dan pengobatan. Saya menyetujui diambil darah untuk pemeriksaan HIV dan kemudian mendiskusikan kembali hasil tes dan cara-cara untuk meningkatkan kualitas hidup terkait HIV dan AIDS.

Saya dengan ini menyetujui tes HIV.

Tanda Tangan / Cap Jempol

Tanda Tangan

(.....)
Nama Klien

(.....)
Nama Petugas/ Konselor HIV

*Lingkari yang sesuai



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

FORMULIR 3

FORMULIR PENOLAKAN TES

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini telah diberi penjelasan dan kegunaan dari pemeriksaan HIV serta prosedurnya, namun saya tidak bersedia atau belum siap untuk melakukan pemeriksaan HIV.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Yang memberi pernyataan

Petugas

(.....)

Nama Klien

(.....)

Nama Petugas



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

FORMULIR 4

FORMULIR PENGAMBILAN HASIL PEMERIKSAAN ANTI HIV

Tanggal :

KODE KLIEN :

Tanda Tangan Pengirim

(.....)



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

FORMULIR 5

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DIAGNOSIS HIV

NOMOR REKAM MEDIS :
 KODE KLIEN :
 UMUR :
 JENIS KELAMIN :
 TANGGAL PERMINTAAN PEMERIKSAAN :
 TANGGAL PEMERIKSAAN :

A. ☐ PEMERIKSAAN ANTI HIV

NAMA REAGENSIA	HASIL PEMERIKSAAN		
1	☐ Non Reaktif	☐ Reaktif	
2	☐ Non Reaktif	☐ Reaktif	
3	☐ Non Reaktif	☐ Reaktif	
HASIL AKHIR:	☐ Non Reaktif	☐ Reaktif	☐ Indeterminate

B. ☐ PEMERIKSAAN CD4 (HANYA UNTUK YANG SUDAH TERDIAGNOSIS HIV)
 HASIL : sel/ul

C. ☐ PEMERIKSAAN PCR KUANTITATIF (VIRAL LOAD)
 HASIL : copies/ml log (copies/ml)

D. ☐ PEMERIKSAAN PCR KUALITATIF (DETEKSI DINI PADA BAYI UMUR 6 MINGGU – 18 BULAN DAN RUJUKAN HIV)
 HASIL : ☐ Detected ☐ Undetected

Mengetahui
 Penanggung Jawab Laboratorium

Petugas Pemeriksa

(.....)

(.....)

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PT. DISA PRIMA MEDIKA

FORMULIR TES DAN KONSELING HIV

NO REKAM MEDIS

NIK

NO REGISTER

RAHASIA

DATA KLIEN			
NAMA			
ALAMAT			
KOTA/KABUPATEN			
PROVINSI			
NAMA IBU KANDUNG			
JENIS KELAMIN		STATUS PERKAHWINAN	
☐ Laki-laki ☐ Perempuan		☐ Kawin ☐ Belum Kawin ☐ Cerai Hidup ☐ Cerai Mati	
STATUS KEHAMILAN		TANGGAL LAHIR (Tgl/Bln/Thn)	
☐ Trimester I ☐ Trimester II ☐ Trimester III ☐ Tidak Hamil ☐ Tidak Tahu		Tahun Bulan Hari	
PENDIDIKAN TERAKHIR		JUMLAH ANAK KANDUNG	
☐ Tidak pernah sekolah ☐ SD/Sederajatnya ☐ SMP/Sederajatnya ☐ SMA/Sederajatnya ☐ Akademi/Perguruan Tinggi/Sederajatnya		Orang	
PEKERJAAN		PASANGAN KLIEN	
☐ Tidak Bekerja ☐ Bekerja, Jenis Pekerjaan: _____		JIKA KLIEN PEREMPUAN KLIEN PUNYA PASANGAN TETAP? ☐ Ya ☐ Tidak	
KELOMPOK RISIKO (Pilih satu yang paling dominan)		JIKA KLIEN LAKI-LAKI	
☐ PS [☐ Langsung ☐ Tidak Langsung] Lamanya Bln/Thn* ☐ Gay/LSL ☐ Pelanggan PS ☐ Pasangan Risti ☐ Lainnya ☐ Waria ☐ Pemasun Lamanya Bln/Thn*		KLIEN PUNYA PASANGAN TETAP? ☐ Ya ☐ Tidak APAKAH PASANGAN HAMIL? ☐ Ya ☐ Tidak	
STATUS KUNJUNGAN		TANGGAL LAHIR PASANGAN	
☐ Datang Sendiri ☐ Tempat Kerja ☐ Kader ☐ Dirujuk ☐ Klp Dukungan ☐ LSM ☐ Pasangan ☐ Lain-Lain		Tahun Bulan Hari	
STATUS RUJUKAN		STATUS PASANGAN	
☐ 1: HIV (+) ☐ 2: HIV (-) ☐ 3: Tidak Diketahui		TANGGAL TES TERAKHIR PASANGAN Tahun Bulan Hari	
Klien pasien TB? ☐ Ya ☐ Tidak		Klien WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan)? ☐ Ya ☐ Tidak	
KONSELING PRA TES (Isikan bila dilakukan konseling (KTS))			
TANGGAL KONSELING PRA TES HIV (Tgl/Bln/Thn)		STATUS KLIEN ☐ Baru ☐ Lama	
ALASAN TES HIV (Boleh diisi lebih dari satu)		☐ Ingin tahu saja ☐ Mumpung gratis ☐ Untuk bekerja ☐ Tes ulang (window period) ☐ Akan menikah ☐ Merasa berisiko ☐ Ada gejala tertentu ☐ Lainnya: _____	
MENGETAHUI ADANYA TES DARI (Pilih yang paling dominan)		☐ Brosur ☐ Koran ☐ TV ☐ Dokter ☐ Teman ☐ Petugas Outreach ☐ Poster ☐ Lay Konselor ☐ Lainnya	
KAJIAN TINGKAT RISIKO :			
HUBUNGAN SEKS VAGINAL BERISIKO		ANAL SEKS BERISIKO	
☐ Ya Kapan: Hr/Bln/Thn* ☐ Tidak		☐ Ya Kapan: Hr/Bln/Thn* ☐ Tidak	
BERGANTIAN PERALATAN SUNTIK		TRANSFUSI DARAH	
☐ Ya Kapan: Hr/Bln/Thn* ☐ Tidak		☐ Ya Kapan: Hr/Bln/Thn* ☐ Tidak	
TRANSMISI IBU KE ANAK		LAINNYA (SEBUTKAN)	
☐ Ya Kapan: Hr/Bln/Thn* ☐ Tidak		☐ Ya Kapan: Hr/Bln/Thn* ☐ Tidak	
PERIODE JENDELA (window periode)		KESEDIAAN UNTUK TES	
☐ Ya Kapan: Hr/Bln/Thn* ☐ Tidak		☐ Ya Kapan: Hr/Bln/Thn* ☐ Tidak	
PERNAH TES HIV SEBELUMNYA (* coret yang tidak perlu)		Di mana: Kapan: Hr/Bln/Thn* Hasil: ☐ Non Reaktif ☐ Reaktif ☐ Tidak Tahu	
☐ Ya ☐ Tidak		☐ Ya ☐ Tidak	
KESEDIAAN UNTUK TES ☐ Ya ☐ Tidak			



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

FORMULIR TES DAN KONSELING HIV

NO REKAM MEDIS

NIK

NO REGISTER

RAHASIA

PEMBERIAN INFORMASI <i>Isikan bila penawaran tes oleh petugas kesehatan (TIPK)</i>			
TANGGAL PEMBERIAN INFORMASI (Tgl/Bln/Thn)			
PERNAH TES HIV SEBELUMNYA (* coret yang tidak perlu)	☐ Ya	Di mana:	Kapan: Hlr/Bln/Thn*
	☐ Tidak	Hasil: ☐ Non Reaktif ☐ Reaktif ☐ Tidak Tahu	
PERNAH TES HIV SEBELUMNYA (* coret yang tidak perlu)	☐ TB	☐ Dermatitis	☐ Herpes
	☐ Diare	☐ LGV	☐ Toksoplasmosis
	☐ Kandidiasis oralesovagial	☐ PCP	☐ Wasting syndrom
	☐ Sifilis	☐ Hepatitis	☐ IMS Lainnya
KESEDIAAN UNTUK TES ☐ Ya ☐ Tidak			
TES ANTIBODI HIV			
TANGGAL TES HIV (Tgl/Bln/Thn)		JENIS TES HIV ☐ Rapid Test ☐ Rapid Test	
HASIL TES R1	☐ Non Reaktif ☐ Reaktif	Nama Reagen:	
HASIL TES R2	☐ Non Reaktif ☐ Reaktif	Nama Reagen:	
HASIL TES R3	☐ Non Reaktif ☐ Reaktif	Nama Reagen:	
KESIMPULAN HASIL TES HIV ☐ Non Reaktif ☐ Reaktif ☐ Indeterminate			
NOMOR REGISTRASI NASIONAL PDP (Diisi bila hasil positif)		Tgl Masuk PDP (dd/mm/yyyy)	
TINDAK LANJUT (TIPK) (Boleh diisi lebih dari satu)			
☐ Rujuk konseling ☐ Rujuk PDP dan PPIA			
☐ Rujuk ke			
Bagaimana Status HIV Pasangan? ☐ HIV (-) ☐ HIV (+) ☐ Tidak Tahu			
KONSELING PASCA TES			
TANGGAL KONSELING PASCA TES (Tgl/Bln/Thn)			
TERIMA HASIL	☐ Ya ☐ Tidak	KAJI GEJALA TB ☐ Ya ☐ Tidak	Jumlah Kondom yang Diberikan Buah
ALASAN TES HIV (Boleh diisi lebih dari satu)	☐ Tes ulang	☐ Rujuk ke Layanan IMS	☐ Rujuk ke Layanan TB
	☐ Rujuk ke PDP	☐ Rujuk ke PPIA	☐ Rujuk ke Profesional
	☐ Rujuk ke Layanan PTRM	☐ Rujuk ke Rehab	☐ Rujuk ke petugas pendukung, yaitu:
	☐ Rujuk ke Layanan LASS	☐ Rujuk ke Layanan LASS	☐ Konseling
☐ 1. Komunitas ☐ 2. LSM () ☐ 3. Kader ☐ 1. Pasangan ☐ 2. Keluarga ☐ 3. Pencegahan positif ☐ 4. Kepatuhan minum obat ☐ 5. Paliatif ☐ 6. Lain-lain			
NAMA KONSELOR/ PETUGAS KESEHATAN			
STATUS LAYANAN ☐ Rumah Sakit ☐ Puskesmas ☐ Klinik			
JENIS LAYANAN ☐ Layanan Menetap ☐ Layanan Bergerak			

— batas akhir formulir —

CEGAH DIRIMU Agar Tidak Tertular HIV dengan "ABCDE":

- 1.A = Abstinence = puasa, yaitu tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah
- 2.B = Be Faithful = setia pada pasangan
- 3.C = Condom = gunakan kondom bagi salah satu pasangan yg telah terinfeksi HIV agar tidak menularkan ke pasangannya
- 4.D = Don't use drugs = tidak menggunakan narkoba
- 5.E = Education = memperbanyak pengetahuan dan informasi tentang kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS

HIV TIDAK DAPAT menular melalui:

1. Bersentuhan, berpelukan, atau berjabat tangan dg Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)
2. Berbagi makanan atau menggunakan alat makan bersama
3. Tinggal serumah dengan ODHA
4. Memakai toilet / WC bergantian
5. Gigitan nyamuk atau serangga lainnya
6. Berenang bersama
7. Bersentuhan dg pakaian/barang milik ODHA



"SAHABAT MENUJU SEHAT "

Banjararum Selatan No 3-9
Mondoroko- Singosari- Kabupaten Malang
Telp : (0341)- 458679, 458916
Customer Service : 0811 349 2244
Humas & Marketing : 0811 350 7164
Email : primahusadamalang@gmail.com
www.rs-primahusada.com

Find us on **Follow Sosial Media Kami :**



RS Prima Husada Malang

@rsprimahusada

rsprimahusadamlg

rsprimahusadamlg



RS Prima Husada Malang

@rsprimahusada

rsprimahusadamlg

rsprimahusadamlg



UM/009

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

HIV - AIDS
(HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)

PKRS

RS PRIMA HUSADA MALANG
Banjararum Selatan No 3-9
Mondoroko- Singosari- Kabupaten Malang
Telp : (0341)- 458679, 458916
Customer Service : 0811 349 2244
Email : primahusadamalang@gmail.com
www.rs-primahusada.com

1418/I-LF/PKRS/IX/2022

KETAHUILAH

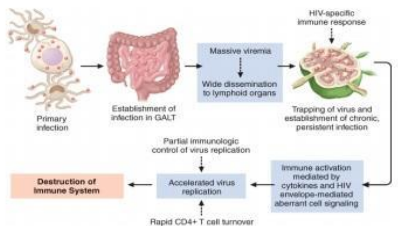
HIV (Human Immunodeficiency Virus) virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tidak mampu melindungi diri dari serangan penyakit lain.

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) kumpulan dari beberapa gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV.

VIRUS TERDAPAT DALAM

- DARAH
- CAIRAN SPERMA (Air Mani)
- CAIRAN VAGINA
- AIR SUSU IBU (ASI) DARI IBU YG TERINFEKSI HIV

Alur Perjalanan Penyakit:



BAGAIMANA HIV MENULAR :

1. Penularan Seksual
 - Melakukan hubungan seksual sebelum menikah
 - Hubungan Seksual yang tidak aman
 - Melakukan hubungan seksual yang bergonta ganti pasangan
2. Kontak langsung dengan darah yang tercemar HIV, misalnya melalui transfusi darah
3. Menggunakan jarum suntik bersamaan bergantian / bekas penderita HIV
4. Menggunakan alat tindik dan alat tatto yang tidak steril
5. Penularan Ibu ke Bayi selama hamil, bersalin, ataupun menyusui



HIV TIDAK MENULAR MELALUI



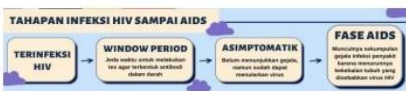
TANDA- TANDA ORANG TERINFEKSI HIV :

Tidak ada tanda-tanda khusus pada orang yang terinfeksi HIV. HIV berubah menjadi AIDS umumnya perlu waktu 5-10 tahun. Selama waktu itu, orang yang terinfeksi tampak sehat seperti orang lain yang tidak terinfeksi HIV. Meskipun tampak sehat dan merasa sehat, orang yang terinfeksi HIV dapat menularkan kepada orang lain.

HIV yang sudah menjadi AIDS akan menunjukkan gejala seperti berikut:

1. Berat badan turun drastic
2. Diare berkelanjutan
3. Pembengkakan pada leher/ketiak
4. Batuk terus menerus
5. Biasanya penderita AIDS akan meninggal 2 tahun kemudian.

TAHAPAN INFEKSI HIV SAMPAI AIDS



" Sahabat Menuju Sehat "